Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno(a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Juan Antonio Figueroa Valenzuela			Sexo	F	M	X
Fecha Nacimiento	29-Nov-2019	Edad actual	4 años	4 meses	País natal:		
Domicilio actual:	villa Cristo redentor. P el refugio 1535			Teléfono	(mamá) 978431150 / (papá) 82831884		
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende ☒ habla ☐ lee ☐ escribe ☐				
Lengua de uso	Español	Grado dominio	comprende ☒ habla ☒ lee ☐ escribe ☐				
Escolaridad actual:	PK- A	Establecimiento	Liceo mixto básica 2				

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista:	18-03-2024	2. Fecha de la entrevista:	18/03/2026.
Nombre:	Cecilia Valenzuela	Nombre:	Cecilia Valenzuela.
Relación con el/la estudiante:	mamá	Relación con el/la estudiante:	mamá.
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)		En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):	
3. Fecha de la entrevista:	18-03-2024	4. Fecha de la entrevista:	
Nombre:	David Figueroa	Nombre:	
Relación con el/la estudiante:	papá	Relación con el/la estudiante:	
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)		En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):	

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista:	18-03-2024	2. Fecha de la entrevista:	18/03/2026
Nombre:	Gabriela Mardones Alfaro	Nombre:	Sofía Ruiz Flores.
Rol/cargo:	Ed. Diferencial	Rol/cargo:	Ed. Diferencial.
3. Fecha de la entrevista:		3. Fecha de la entrevista:	
Nombre:		Nombre:	
Rol/cargo:		Rol/cargo:	

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

Ingreso al Programa de Integración Escolar 2024.

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☐ Sí (especificar)

Pediatría:	Psicología:
Kinesiología:	Psiquiatría:
Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología: FIADI / 10 sesiones /	Terapia Ocupacional:
Neurología:	Otro:

(no realizan informes en el consultorio) Fsg
el año 2023 (42 80 27 33). progresa.)

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: ☒ normal ☐ inducido ☐ fórceps ☐ cesárea (señalar motivo) 40 smanas

Tuvo asistencia médica durante el parto? ☐ SI ☐ NO [illegible] normal. | Peso: 3,980 | Talla: 50 cm

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:

todo normal.

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Sí	[✓ No]	Traumatismos	Sí	[✓ No]	Encefalitis	Sí	[✓ No]
Obesidad	Sí	[✓ No]	Intoxicación	Sí	[✓ No]	Meningitis	Sí	[✓ No]
Fiebre alta	Sí	[✓ No]	Enfermedad respiratoria	Sí	[✓ No]	Otra(s)		
Convulsiones	Sí	[✓ No]	Asma	Sí	[✓ No]			
Hospitalizaciones	[✓ Sí]	No	Especifique motivos y duración:					

Se realizaron controles periódicos de salud	[✓ Sí]	No	Vacunas	[✓ Sí]	No

Observaciones: por una infección urinaria. (a los 6 meses. de edad.)

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza: 6 m.	Se sienta sólo/a: 9 m.	Camina sin apoyo: 1 a, 4 m
Primeras palabras: Al año.	Primeras frases: 2 años y algo	Se viste solo/a: 3 a, 6 m.

Controla esfínter vesical TATA
Diurno: ______ Nocturno: ______

Controla esfínter anal
Diurno: ______ Nocturno: ______

Observaciones:

2 años y medio.
día y noche.

En su actividad motora general se aprecia:
☐ normal ☐ activo ☒ hiperactivo ☐ hipoactivo

Su tono muscular general se aprecia:
☒ normal ☐ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	[✓ Sí]	No	Caídas frecuentes	Sí	[✓ No]	Dominancia lateral izquierdo/derecha alt.	Sí	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	[✓ Sí]	No	Prensión	[✓ Sí]	No	Pinza	Sí	[✓ No]
Ensarta	[✓ Sí]	No	Dibuja	[✓ Sí]	No	Escribe Rayas [illegible]	Sí	[✓ No]

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	[✓ Sí]	No	Manipula y Explora objetos	[✓ Sí]	No
Demanda objetos y compañía	[✓ Sí]	No	Comprende prohibiciones	[✓ Sí]	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	[✓ Sí]	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	Sí	[✓ No]

Observaciones:

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.3. Visión - Audición: No

			No		
Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	[✓ Sí]	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	[✓ Sí]	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	[✓ No]	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	[✓ Sí]	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	[✓ No]	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	[✓ Sí]	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí	[✓ No]	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	[✓ No]
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	[✓ Sí]	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Sí	[✓ No]
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	[✓ No]	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	[✓ No]
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	[✓ No]	La pronunciación oral es adecuada (No se le entienda bien algunas palabras)	Sí	[✓ No]
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	[✓ No]	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	[✓ No]

Observaciones:

5.4. Desarrollo del Lenguaje

El niño (a) se comunica preferentemente en forma

☐ oral ☐ gestual ☒ mixto ☐ otro (especifique):

Características del lenguaje expresivo

Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	[✓ Sí]	No	Emite/produce frases	[✓ Sí]	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	Sí	[✓ No]	Relata experiencias	[✓ Sí]	No
Emite palabras/produce señas	[✓ Sí]	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	Sí	[✓ No]

(+o meos) algunas palabras no se le entienden.

Características del lenguaje comprensivo

Identifica objetos	[✓ Sí]	No	Sigue instrucciones simples	[✓ Sí]	No
Identifica personas	[✓ Sí]	No	Sigue instrucciones complejas	[✓ Sí]	No
Comprende conceptos abstractos	Sí	[✓ No]	Sigue instrucciones grupales no sabemos	Sí	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	[✓ Sí]	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	[✓ Sí]	No

Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos):

Observaciones:

con personas externas sí es más esquivo

5.5. Desarrollo Social

Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	[✓ Sí]	No	Se relaciona en forma colaborativa	[✓ Sí]	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	[✓ Sí]	No	Respeta normas sociales	[✓ Sí]	No
Participa en actividades grupales	[✓ Sí]	No	Respeta normas escolares No se	Sí	No
Opta por trabajo individual	[✓ Sí]	No	Muestra sentido del humor	[✓ Sí]	No
Presenta lenguaje ecolálico	Sí	[✓ No]	Movimientos estereotipados	Sí	[✓ No]
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	Sí	[✓ No]	Pataletas frecuentes A veces	Sí	No

Ante los siguientes estímulos su reacción es:

Luces: ☒ natural ☐ desmesurada	**Sonidos:** ☒ natural ☐ desmesurada	**Personas extrañas:** (solo es mas esquivo en algunos momentos cuando no conoce a las personas) ☒ natural ☐ desmesurada

Observaciones:

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante NO

Vacunas al día	[✓ Sí]	No	Trastorno motor	Sí	[✓ No]
Epilepsia	Sí	[✓ No]	Problema bronco-respiratorio	Sí	[✓ No]
Problemas cardiacos	Sí	[✓ No]	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	[✓ No]
Paraplejia	Sí	[✓ No]	Trastorno emocional	Sí	[✓ No]
Pérdida auditiva	Sí	[✓ No]	Trastorno conductual	Sí	[✓ No]
Pérdida visual	Sí	[✓ No]	Otro (especifique):		

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique):

Alimentación: ☐ normal ☐ "malo/a" para comer ☒ bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)

Peso (apreciación del informante): ☐ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad un poquito no en exceso

Sueño: ☒ normal ☐ tranquilo ☐ inquieto **Horas que duerme:** (acostado) 8 Horas

☐ insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos

☐ sonambulismo ☑ despierta de buen humor

Duerme: ☐ solo ☒ acompañado

(Especifique): con los papás

Humor/comportamiento ***(señale el comportamiento habitual)***

☑ alegre ☑ juguetón/bromista ☑ risueño(a) ☐ triste NO ☑ serio ☑ rebelde cuando lo molestan ☐ apático ☐ violento(a) NO.

Otro:

Observaciones:

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.

Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Cecilia Valenzuela	Mamá	29	4to medio	Conductora.
2. David Figueroa	Papá	25	4to medio	Conductor
3. Millaray	Hermana mayor	13		Estudiante 8vo básico
4. Gonzalo Figueroa	Hermano menor	6		Estudiante 1º A.
5.				
6.				
7.				
8.				

Antecedentes de Salud de la Familia

(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):

NO.

Observaciones:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar

Edad de ingreso al sistema escolar	2 años	Asistió a jardín infantil — Desde los 2 años. (desde el 2021) hasta el 2023	[✓ Sí]	No
Nº de colegios en que ha estudiado	2	Modalidad de enseñanza Regular ☒ Especial ☐ Técnica ☐:		

Motivo de los cambios: De jardín al colegio

Ha repetido curso/s	Sí	[✓ No]	Curso(s)	Motivo:

Situación actual

Nivel/curso actual	PKA		**Dificultad de aprendizaje**	Sí	[✓ No]	**Dificultad para participar**	Sí	[✓ No]	**Conducta disruptiva**	Sí	[✓ No]
Asiste regularmente	[✓ Sí]	No	Asiste con agrado	[✓ Sí]	No	Apoyo familiar en tareas	[✓ Sí]	No	Amigos (as)	Sí solo una	No no

(en el colegio no saben)

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?
☒ satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) ....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?
☒ apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐ compasión ☐ tensión ☐ otra ....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?
☒ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra .... enseñarle todo de buena manera.

Especifique el tipo de refuerzos o premios:
☒ expresiones afectivas ☐ alimentos preferidos ☐ ver TV ☐ juguetes ☐ tiempo libre ☐ otro(s)............

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?
☒ madre ☒ padre ☐ hermanos/as ☐ Otros familiares ☐ Otros profesionales ....

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?
☒ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?
☒ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

Contar.
Los colores. } maneja